# DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

**IDENTIFICACIÓN**

**Paciente:** RORY RICHARD POLAK **Identificación** PT A61960608
**Edad:** 65 AÑOS **Empresa:** PARTICULAR
**Sala:** SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

**Sede de Atención:** SEDE PRINCIPAL

**CIRUGÍAS**

| CANT | CÓDIGO | NOMBRE DE LA CIRUGÍA | Grupo Quirúrgico | UVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **GE441302** | **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA** | ERR | |

**Cirujano:** JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
**Vía:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **GE452301** | **COLONOSCOPIA TOTAL** | ERR | |

**Cirujano:** JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
**Vía:**

**DESCRIPCIÓN CIRUGÍA**

**CIRUJANO** ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
**GE441302** **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
**GE452301** **COLONOSCOPIA TOTAL**
**Dx Preoperatorio:** Z980 ESTADO DE DERIVACION INTESTINAL O ANASTOMOSIS

**Dx Postoperatorio:** K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO

**Tipo de Herida:** LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
**Cantidad de Sangrado:** 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
**Clasificación de riesgo quirúrgico :** **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
**Realización Acto Quirúrgico:** **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
**Hora Inicio** 06:45:00 **Hora Final** 07:41:00
**Tiempo de Perfusión:** 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

**Descripcion Quirúrgica:**
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Llenura postprandial inmediata
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Se observo hiato amplio vs hernia hiatal pequeña con mucosa herniaria normal.
ESTOMAGO: Estado post bypass gástrico. Remanente gástrico pequeño con escasas erosiones diseminadas. Anastomosis gastroyeyunal amplia pero edematizada e hiperemica. Se explora bastón sin lesión que comprometa mucosa o distensibilidad. Se explora asa alimentaria aprox 30 cm sin lesión que comprometa mucosa o distensibilidad.
DUODENO: No se explora.
BIOPSIAS: FRASCO 1: Remanente gastrico. FRASCO 2: Anastomosis gastroyeyunal
***CONCLUSION:
1. ESTADO POST BYPASS GASTRICO
2. HIATO AMPLIO VS HERNIA HIATAL PEQUEÑA
3. GASTRITIS EROSIVA DE REMANENTE
4. ANASTOMOSIS GASTROYEYUINAL AMPLIA EDEMATIZADA A ESTUDIO

****COLONOSCOPIA****
***INDICACIÓN: Dolor abdominal / Masa Inguinal?
INSPECCIÓN: se evidencia hernia inguinoescrotal izquierda que reduce facilmente.
TACTO RECTAL: paquete hemorroidal
COLONOSCOPIA: Explorado hasta colon transverso medio por imposibilidad para avanzar por limitacion a la movilizacion por hernia inguinoescrotal izqueirda que no permite franquear a proximal. Se realiza multiples intentos en diversas posiciones, tecnica de inmersion pero por riesgo de perforacion se suspende procedimiento. se observaron algunos orificios diverticulares sin edema sin sangrado. Materia

## DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

fecal semisolida que evacua con el lavado. Canal anal paquete hemorroidal. Procedimiento sin complicaciones aparentes. Preparación Boston CT: 3, CI: 3 6/6

***CONCLUSIÓN:
1. ASA INFRANQUEABLE EN TRANSVERSO MEDIO POR HERNIA INGUINOESCROTAL IZQUIERDA
2. DIVERTICULOSIS DE TRAYECTO VALORADO
3. HEMORROIDES GRADO I/IV
Observaciones
Se evidencia hernia inguinoescrotal izquierda que no permite franquear equipo. Se debe realizar correccion quirurgica y posterior nueva colonoscopia.

**Complicaciones :** **SI** ☐ **NO** ☒

**Tejidos enviados a patología :** **SI** ☒ **NO** ☐

FRASCO 1: REMANENTE GASTRICO. FRASCO 2: ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****